Resumo de erros — Agendamento

Todas as telas do módulo Agendamento · 14/07/2026 · Linguagem simples e direta, sem termos técnicos

Cód.	Gravidade	Onde (tela)	O que é o erro	O que afeta no sistema
CRIT-01	Crítica	Agenda clássica — botão 'Novo agendamento' / tecla N	Quando alguém cria um agendamento digitando o horário na mão (em vez de clicar num horário livre já pronto), o sistema não 'usa' aquele horário livre — cria uma segunda linha por cima, e o horário livre continua aparecendo como disponível.	Dois pacientes podem ficar marcados no mesmo horário com o mesmo médico, sem o sistema avisar nada.
CRIT-02	Crítica	Agenda clássica — mesmo caminho do erro anterior	Quando dois atendentes tentam agendar ao mesmo tempo nesse horário 'digitado na mão', não existe nenhuma trava no banco de dados que impeça os dois de conseguirem.	Overbooking real — dois pacientes marcados no mesmo horário do mesmo médico, sem erro para nenhum dos dois atendentes.
CRIT-03	Crítica	Agenda Express (uma terceira forma de marcar consulta)	Essa tela foi feita separada das outras duas e não tem nenhuma das proteções delas — nem trava contra agendamento duplo, nem bloqueio de cadastro incompleto, nem checagem de convênio devendo.	Mesmo risco de overbooking, além de permitir agendar paciente com cadastro incompleto ou convênio inadimplente.
CRIT-04	Crítica	Sistema por trás de todas as telas de agendamento (interno)	A checagem de 'esse horário está dentro do expediente do médico?' só acontece se a própria tela pedir — o sistema não confere sozinho por padrão.	Em teoria, dá para criar agendamento fora do horário do médico simplesmente pedindo ao sistema para não conferir.
CRIT-05	Crítica	Banco de dados (parte técnica interna)	O banco só confere se a pessoa tem permissão de usar a Agenda — não confere se o horário está disponível nem se já tem outro paciente marcado ali.	Se alguém acessar o sistema por fora das telas normais, consegue criar agendamento em qualquer horário, mesmo indisponível ou ocupado.
CRIT-06	Crítica	Agenda V2 (versão nova, em teste) — botão de check-in	Esse botão tenta salvar um status 'em atendimento' que não existe no banco de dados — foi criado na tela, mas nunca criado no banco.	O botão de check-in da Agenda V2 não funciona — dá erro toda vez que alguém tenta usar.
CRIT-07	Crítica	Agenda V2 — reagendar consulta	Reagendar faz 3 operações separadas no banco, sem serem 'tudo ou nada'. Se falhar no meio, o horário novo pode ficar travado permanentemente.	Horário 'fantasma' preso, sem ninguém conseguir usar; dois atendentes reagendando ao mesmo tempo podem colocar pacientes diferentes no mesmo horário.
CRIT-08	Crítica	Agenda clássica e V2 — cancelar consulta ou marcar falta	Cancelar ou marcar falta num agendamento já pago não pede confirmação nem bloqueia nada — o dinheiro continua 'recebido' no financeiro mesmo com a consulta cancelada.	Risco de cobrar o paciente duas vezes se ele remarcar; relatório financeiro mostra dinheiro recebido de consulta que não vai acontecer.
CRIT-09	Crítica	Fila de Triagem (Enfermagem) e tela de Atendimento do médico	Quando um agendamento é cancelado, ele continua aparecendo na fila de espera da triagem como se o paciente estivesse esperando; se já pago, o sistema pode até 'promover' sozinho para 'em atendimento'.	Enfermagem pode chamar e atender paciente com consulta cancelada; médico pode 'atender' e criar prontuário de consulta cancelada.
CRIT-10	Crítica	Link público de check-in enviado ao paciente	Esse link não confere se a consulta foi cancelada nem se é o dia certo, e pode ser usado quantas vezes quiser.	Qualquer pessoa com o link pode reabrir o fluxo de uma consulta já cancelada, ou fazer check-in em dia errado, sem o sistema perceber.
CRIT-11	Crítica	Função interna do banco usada pelo robô de WhatsApp (Nina)	Essa função devolve nome, CPF, telefone e data de nascimento de pacientes — e está liberada para qualquer pessoa na internet chamar, sem precisar fazer login.	Vazamento de dados pessoais (LGPD) de pacientes de qualquer clínica do sistema.

Cód.	Gravidade	Onde (tela)	O que é o erro	O que afeta no sistema
ALTA-01	Alta	Caixa — pagamento de vários atendimentos de uma vez	Se der erro ao dividir o valor entre os atendimentos do grupo, o sistema não desfaz nada — marca todo mundo como 'pago' e imprime a guia mesmo assim.	Atendimentos marcados como pagos sem lançamento financeiro por trás — repasse do médico nunca aparece.
ALTA-02	Alta	Agenda clássica e V2 — menu de status de qualquer consulta	O menu deixa mudar para qualquer status, inclusive cancelar uma consulta já 'realizada' com repasse pago, sem as checagens de segurança que existem para esse caso.	Contorna o único fluxo que trata estorno de repasse médico corretamente.
ALTA-03	Alta	Agendamentos de recursos de enfermagem (salas/equipamentos)	Esse tipo de agendamento pula a checagem de horário disponível E a trava contra dois atendentes mexendo ao mesmo tempo.	Dois pacientes podem ser colocados no mesmo recurso/horário sem erro nenhum.
ALTA-04	Alta	Prontuário e financeiro do atendimento	O prontuário e o lançamento financeiro não guardam qual agendamento os originou.	Se o paciente teve duas consultas no mesmo dia, fica impossível provar qual prontuário é de qual consulta.
ALTA-05	Alta	Check-in (tela interna da recepção)	Confirmar presença sobrescreve o status sem checar se alguém já mudou entretanto, e a tela não atualiza sozinha.	Paciente já atendido pode ser 'devolvido' à fila de espera por engano.
ALTA-06	Alta	WhatsApp / robô Nina	Se o WhatsApp reenviar a mesma mensagem, o sistema responde de novo, gerando resposta e custo duplicados.	Paciente recebe a mesma resposta 2 vezes; custo de IA e mensagem cobrado em dobro.
ALTA-07	Alta	Banco de dados — tabela de agendamentos (técnico)	Não existe trava impedindo salvar um agendamento com hora de término antes da hora de início.	Dado corrompido pode entrar no sistema sem ninguém perceber.
ALTA-08	Alta	Função interna que confere dívida no Cartão de Benefícios	Qualquer usuário logado, de qualquer clínica, pode consultar essa função para ver a situação financeira de paciente de outra clínica.	Vazamento de dado financeiro entre clínicas diferentes.
ALTA-09	Alta	Banco de dados — respostas de anamnese do paciente	Excluir um agendamento antigo apaga junto todas as respostas de anamnese vinculadas, sem aviso e sem log.	Perda definitiva de dado clínico do paciente.
ALTA-10	Alta	Caixa — cobrança de atendimento	A checagem 'já foi pago?' é feita de 3 jeitos diferentes, e dois deles não descontam pagamentos já estornados.	Depois de um estorno legítimo, o Caixa mostra 'PAGO' para sempre e não deixa cobrar de novo.
ALTA-11	Alta	Fila do Caixa	O valor sugerido pelo Cartão de Benefícios é calculado diferente do resto do sistema, ignorando carência e limite de uso.	Pode sugerir cobrar menos (ou de graça) de um paciente sem direito ao desconto ainda.
ALTA-12	Alta	Criação de agendamento vindo de um orçamento	O vínculo com os itens do orçamento é feito depois de já salvar o agendamento — se falhar, vira só aviso.	Orçamento pode ficar com itens 'perdidos', nunca marcados como agendados nem cobrados.
ALTA-13	Alta	Totem de autoatendimento	Com mais de uma consulta no dia, o totem sempre confirma presença na mais cedo — mesmo cancelada — em vez da mais próxima do horário atual.	Paciente confirma presença na consulta errada.
ALTA-14	Alta	Triagem — Enfermagem	Clique duplo em 'Chamar' gera duas senhas; nada impede salvar a triagem duas vezes para o mesmo atendimento.	Fila com senhas repetidas; histórico de triagem duplicado/confuso.
MED-01	Média	Agenda clássica vs. Agenda V2	As duas versões têm código separado para cancelar/reagendar — corrigir um bug numa não corrige na outra.	Correções não valem para a outra versão; retrabalho e confusão.
MED-02	Média	Agenda clássica (técnico)	Um trecho do código desliga a checagem de tipo, escondendo possíveis erros.	Erro futuro nesse ponto pode passar despercebido até dar problema em produção.

Cód.	Gravidade	Onde (tela)	O que é o erro	O que afeta no sistema
MED-03	Média	Criação de agendamento (todas as telas)	Não confere se o paciente já tem outro agendamento no mesmo horário, nem bloqueia data já passada.	Paciente com compromissos conflitantes; consultas retroativas sem querer.
MED-04	Média	Disponibilidades — 'Gerar agenda'	A geração de horários é feita no computador do usuário, não no servidor, contrariando a documentação interna.	Sem ponto único de controle da regra de geração.
MED-05	Média	Geração de horários vs. checagem de disponibilidade (técnico)	Um lado calcula o dia pelo fuso do navegador, outro pelo fuso do servidor.	Perto de 21h, pode haver descompasso sobre qual dia está sendo considerado.
MED-06	Média	Sistema por trás da agenda (técnico)	Horário 'BLOQUEIO' é tratado igual a 'DISPONÍVEL' — seria oferecido para agendar.	Bloqueio manual futuro funcionaria ao contrário do esperado se não corrigido antes.
MED-07	Média	Disponibilidades	Não existe forma de bloquear pontualmente um período do médico sem mexer na semana inteira.	Recepção precisa fazer na mão, com risco de esquecer de desfazer.
MED-08	Média	Disponibilidades — cadastro de horários semanais	O sistema deixa cadastrar regras de horário que se contradizem, sem avisar.	Agenda gerada pode sair com horários duplicados/incoerentes.
MED-09	Média	Disponibilidades — geração de agenda	Lista de feriados fixa (só 9), duplicada em 2 arquivos, sem feriados móveis nem estaduais/municipais.	Agenda pode incluir/excluir dias errados sem aviso.
MED-10	Média	Reagendamento	Paciente reagendado para outro dia some da fila do dia atual sem aviso.	Confusão operacional — recepção não sabe que ele não vem mais hoje.
MED-11	Média	Tela de Atendimento do médico (técnico)	Atualização automática não filtra por clínica.	Não vaza dado, mas gera carga desnecessária no sistema.
MED-12	Média	WhatsApp / robô Nina	Desligar o WhatsApp nas configurações não impede o robô de continuar respondendo.	Comportamento inesperado — clínica acha que desligou, mas não desligou.
MED-13	Média	Criação de agendamento (técnico)	Dois campos internos indicam 'qual clínica', sem garantia de que batem entre si.	Risco baixo hoje, mas inconsistência que pode causar erro futuro.
MED-14	Média	Banco de dados (técnico)	Nada impede usar médico de uma clínica em agendamento de outra.	Dado incoerente que confunde relatórios de repasse e ocupação.
MED-15	Média	Banco de dados — pacientes e financeiro	Registro de auditoria foi desligado para essas tabelas em junho e nunca religado.	Alterações em dados de pacientes e financeiro não ficam mais registradas.
MED-16	Média	Estorno financeiro	Estorno em 3 passos separados; falha vira aviso técnico invisível, sem desfazer o que já foi feito.	Pode sobrar inconsistência entre financeiro estornado e agendamento ainda mostrado como pago.
MED-17	Média	Caixa — totais e resumos	Duas partes do resumo financeiro calculam totais de formas diferentes.	Números do resumo podem não bater com o saldo real (não confirmado com dados reais).
MED-18	Baixa — validar regra	Cancelamento de consulta	Cancelar não libera automaticamente o horário — continua 'ocupado' até apagar manualmente.	Pode ser proposital, mas pode confundir. Confirmar com a clínica.
BAIXA-01	Baixa	Agenda V2 (técnico)	Sobrou uma importação de código não usada.	Nada — é só limpeza de código.
BAIXA-02	Baixa	Agenda clássica (técnico)	Algumas operações não repetem a checagem 'é da minha clínica?' na tela (coberta hoje por outra camada).	Nenhum problema hoje; falta camada extra de segurança.

Cód.	Gravidade	Onde (tela)	O que é o erro	O que afeta no sistema
BAIXA-03	**Baixa**	Disponibilidades	Duração da consulta configurada só por médico, não por procedimento.	Limitação do sistema, não erro.
BAIXA-04	**Baixa**	Disponibilidades	Sem jeito claro de marcar vários pacientes no mesmo horário (ex.: exames em lote).	Limitação para clínicas com atendimento em grupo/lote.

O que significa cada gravidade

Gravidade	O que significa
Crítica	Pode causar consulta duplicada, vazamento de dado de paciente ou falha que impede o uso normal do sistema. Corrigir com prioridade máxima.
Alta	Risco de errar dinheiro, perder dado clínico ou causar falha grave de operação. Corrigir com prioridade.
Média	Comportamento errado visível ao usuário ou dívida técnica relevante, mas sem quebrar o uso do sistema.
Baixa	Detalhe técnico, organização do código, ou limitação de funcionalidade — não é um erro no sentido estrito.
Baixa — validar regra	Não dá para saber se é erro ou é assim mesmo — precisa perguntar para a clínica antes de mexer.

Nenhuma alteração foi feita no código ou no banco de dados. Este documento resume, em linguagem simples, o relatório técnico completo (auditoria-agendamento-2026-07-14.pdf, 48 páginas).